

Melanoma Maligno

Guía de Estudio Detallada y Atlas Diagnóstico

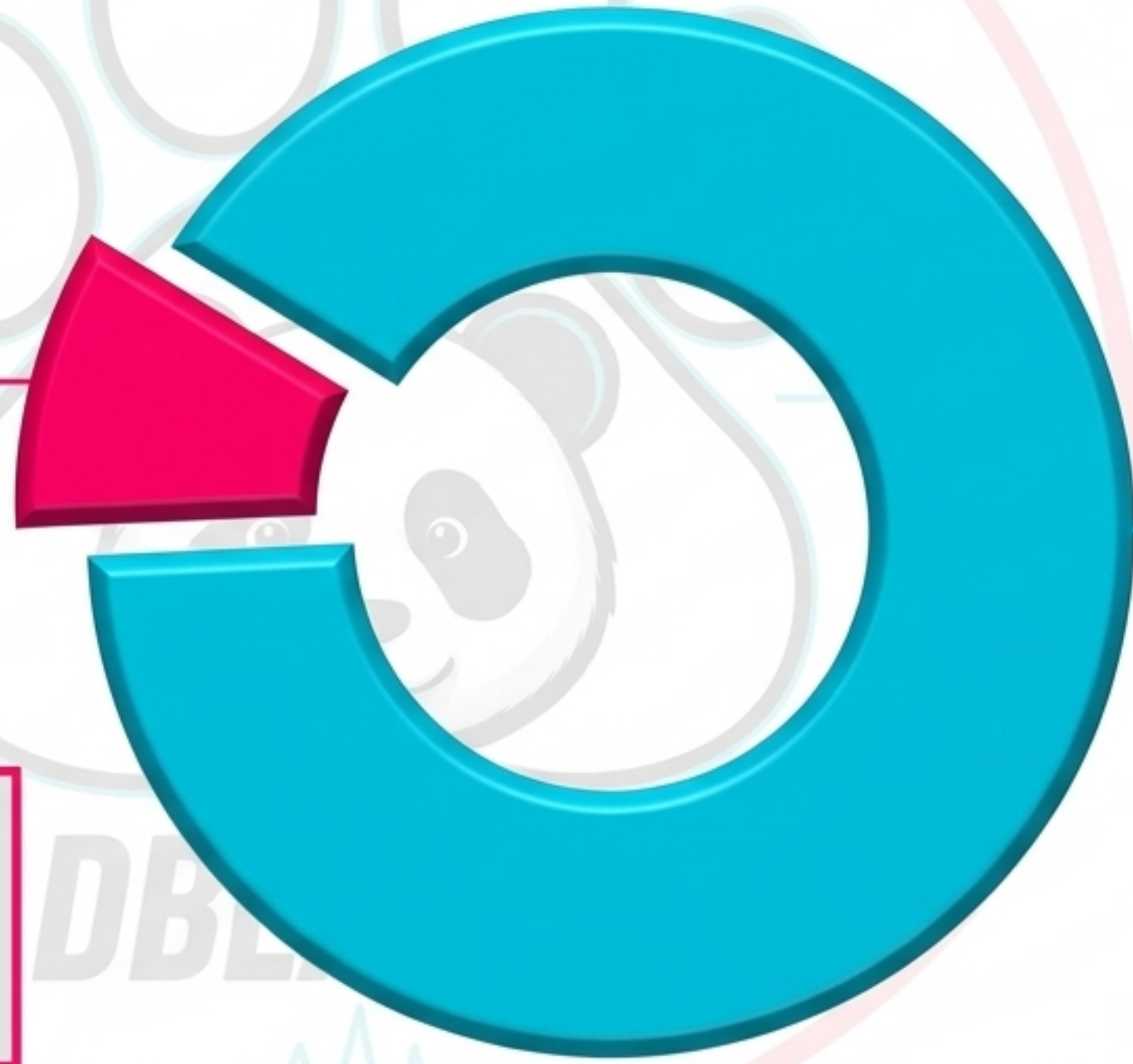
BADBEAR.MED

El Cáncer de Piel Más Agresivo a Nivel Mundial

10% Mucosas y otros

Estructuras derivadas de la cresta neural: vulva, vagina, recto, retina, senos nasofaríngeos y meninges.

Alta capacidad metastásica rápida: Invasión sistémica y alta mortalidad.



Genética, Fototipos y Factores Desencadenantes



Mutaciones Genéticas

- BRAF (50% de los casos)
- NRAS (15% de los casos)



Fototipos y Melanina

Fototipos claros (I y II) tienen mayor riesgo por baja protección natural, pero existe una alta incidencia en fototipos oscuros (IV) en Latinoamérica.



Conteo de Nevos

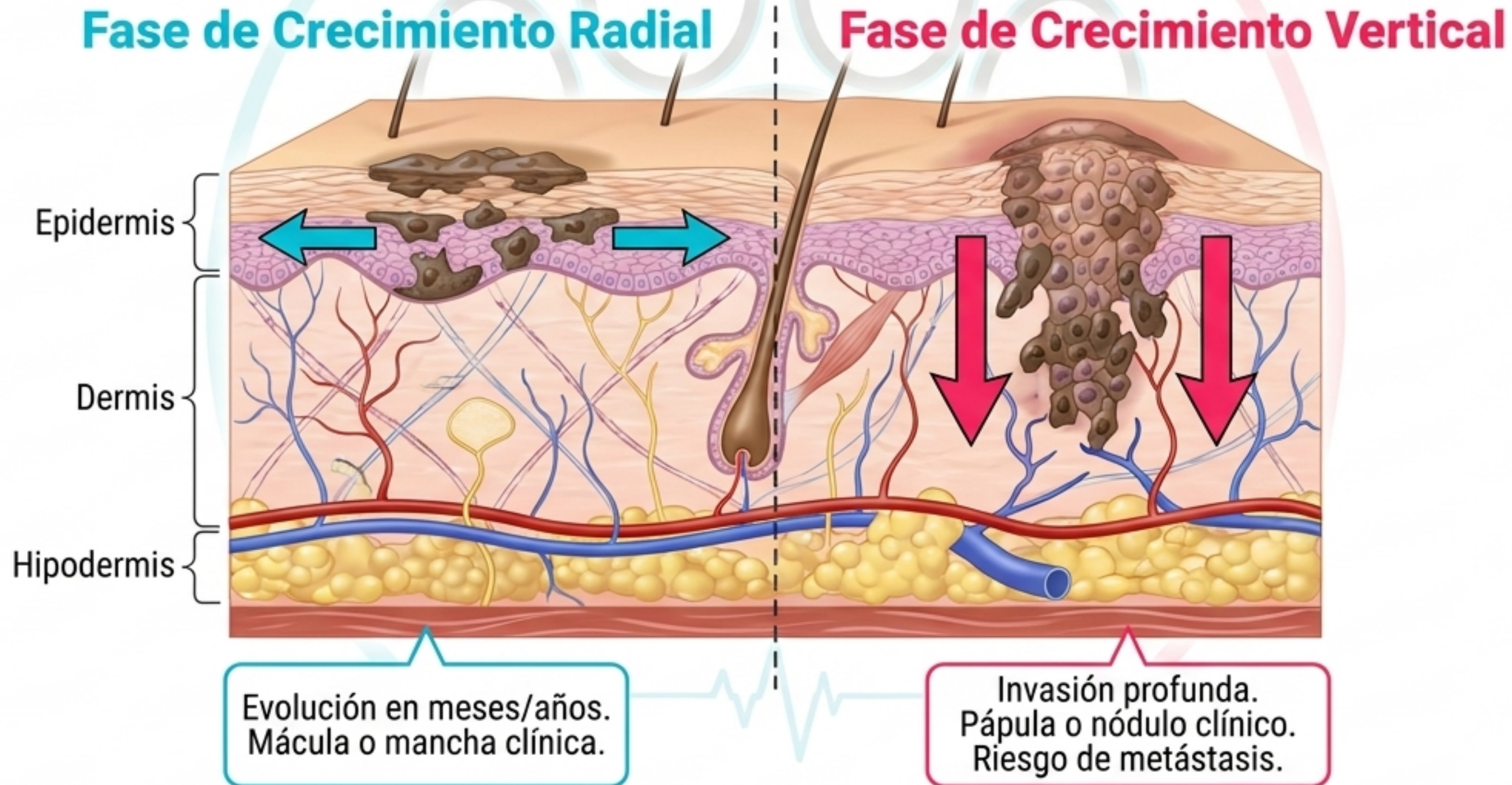
>50 nevos en el cuerpo o presencia de nevos melanocíticos congénitos (especialmente gigantes) exigen seguimiento riguroso.



Inmunosupresión

Pacientes con VIH o pacientes trasplantados presentan un riesgo exponencialmente mayor.

Fisiopatología: Fases de Proliferación e Invasión



Diagnóstico Clínico: Los Criterios ABCDE



A



Asimetría

B



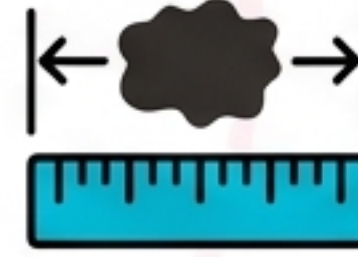
Bordes irregulares

C



Color heterogéneo
(rojo, oscuro, gris,
blanco)

D



Diámetro > 6mm

E



Evolución

Clinical Pearl

Signo del Patito Feo: Una lesión que visualmente no encaja o destaca abruptamente frente al resto de los nevos del paciente.

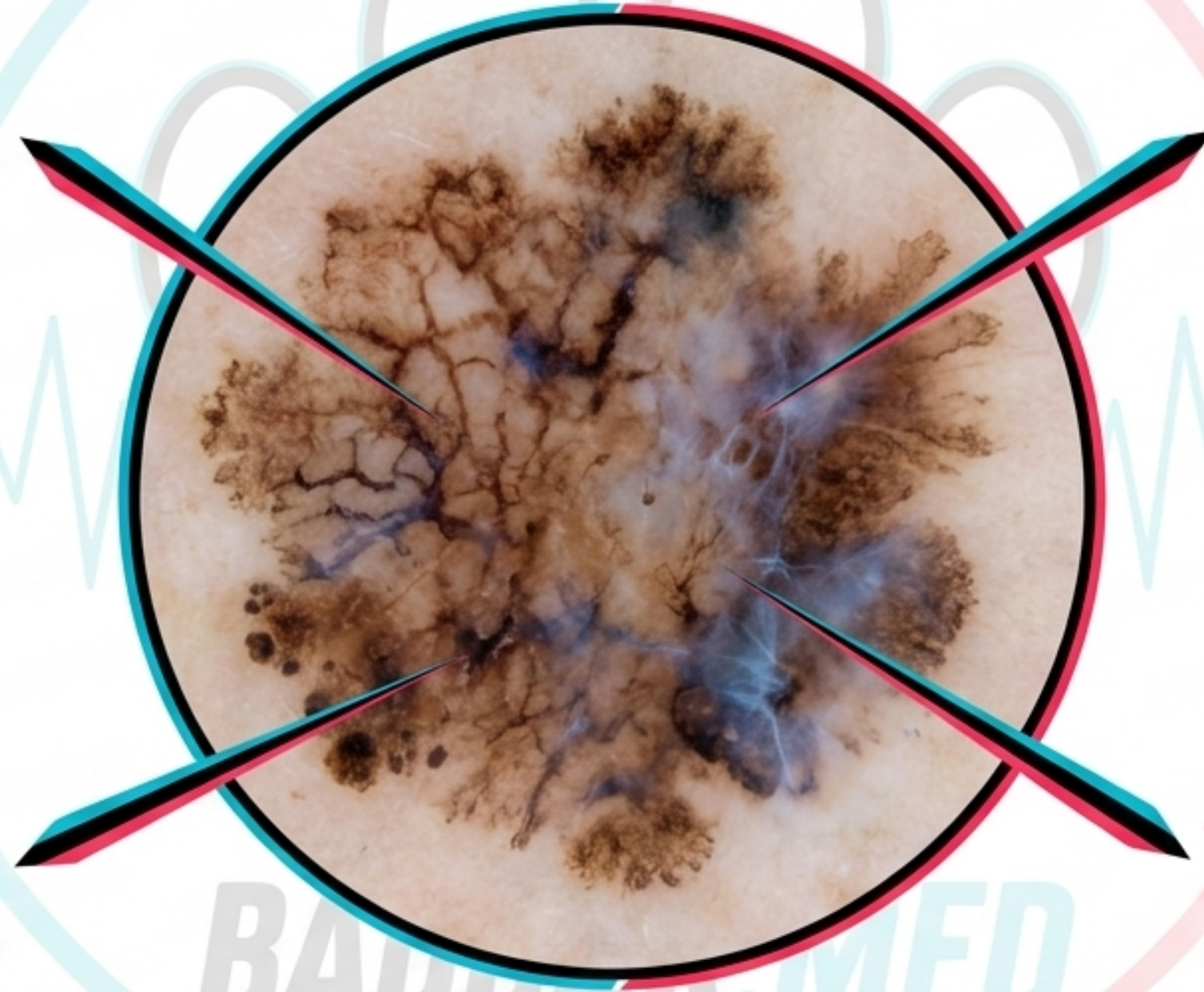
Criterios Dermatoscópicos de Malignidad

Red de pigmento atípico
(Aspecto reticulado irregular)

Pseudópodos
(Prolongaciones atípicas periféricas)

Glóbulos periféricos
(Puntos negruscos en los bordes)

Velo blanco-azulado / Zonas de regresión
(Áreas pálidas o grisáceas que indican involución del pigmento, signo de mal pronóstico)



Variante 1: Melanoma de Extensión Superficial

Frecuencia: La variante más común a nivel mundial.

Demografía: Mujeres (predominio en miembros inferiores) y Hombres (predominio en tronco/espalda).

Evolución: Comienza como mácula asimétrica multicolor, evolucionando a pápula/nódulo en fase de crecimiento vertical.

Metástasis: Precoz a ganglios linfáticos regionales.



Variante 2: Léntigo Maligno

Demografía: Adultos mayores (>60 años).

Localización: Zonas fotoexpuestas crónicas (cara, mejillas, frente, zona pretemporal).

Evolución: Fase de crecimiento radial (horizontal) muy prolongada. Metástasis más tardías.

Signo de Alarma: Zonas de regresión (áreas donde 'desaparece' el pigmento simulando mejoría, pero indica invasión a dermis profunda).



Variante 3: Melanoma Lentiginoso **Acral**

- **Epidemiología Clave:** La variante más frecuente en Latinoamérica, hispanoamericanos y asiáticos.
- **Etiología:** Fuerte factor genético, independiente de la radiación ultravioleta.
- **Localización:** Plantas de los pies, región interdigital y palmas.
- **Comportamiento:** Altamente agresivo. Fase radial muy corta e inicio rápido de la fase vertical. Metástasis linfática y hemática precoz.



Variante 4: Melanoma Subungueal



Melanoniquia Longitudinal: Banda pigmentada >3mm de grosor que se ensancha rápidamente.

Signo de Hutchinson: Pigmentación oscura que se extiende hacia el pliegue proximal de la uña (piel circundante). Indicador crítico de biopsia.

Signo de Punta de Lápiz: La base en la matriz proximal es más ancha que la zona distal.

Variantes 5 y 6: Nodular y Mucoso (Alta Agresividad)

Melanoma Nodular



- **Crecimiento vertical puro** desde el inicio (sin fase radial aparente).
- **Domo friable** con ulceración temprana y sangrado (frecuentemente confuso con carcinoma basocelular).

Melanoma Mucoso



- **Labial, genital, anorrectal.**
- A menudo **asintomático** y confundido con aftas benignas.
- **Diagnóstico tardío severo:** Supervivencia a 5 años menor al 20%.

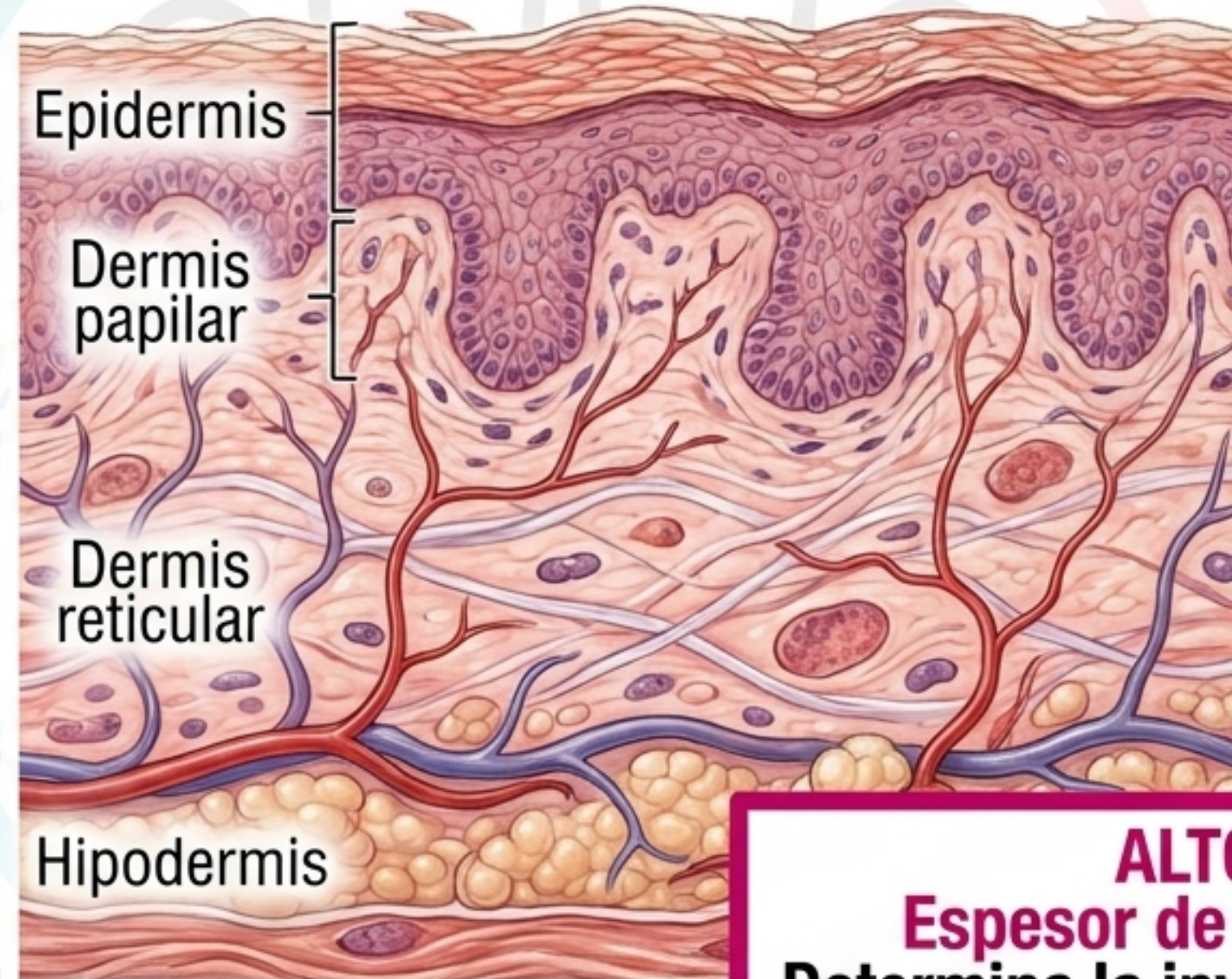
Matriz de Síntesis Diagnóstica

Variante	Demografía / Factor Principal	Localización Común	Patrón de Crecimiento	Nivel de Agresividad
Extensión Superficial	Mundialmente más común	Extremidades (M), Tronco (H)	Radial seguido de vertical	Moderada
Léntigo Maligno	Adultos mayores (>60)	Cara, zonas fotoexpuestas	Radial prolongado	Moderada (mal pronóstico si hay regresión)
Lentiginoso Acral	LATAM / Asiáticos (Genético)	Plantas de los pies	Vertical rápido	Muy Alta
Subungueal	Trauma previo descartado	Matriz ungueal	Ensanchamiento longitudinal	Alta (Signo Hutchinson)
Nodular	>50 años	Zonas expuestas	Vertical puro	Muy Alta
Mucoso	Subdiagnosticado	Labios, genitales	Ulceración rápida	Extrema (<20% sobrevida)

Histopatología y Estadificación

Niveles de Clark

- I: Epidermis
- II: Dermis papilar
- III: Interfaz papilar-reticular
- IV: Dermis reticular
- V: Hipodermis



ALTO RIESGO:
Espesor de Breslow > 4mm.
Determina la invasión tumoral directa
y el pronóstico de sobrevida.

Metástasis, Pronóstico y Manejo Terapéutico

Biopsia de ganglio centinela



Invasión linfática



**Metástasis sistémica
(Cerebro y Pulmón - causa principal de fatalidad)**

Pronóstico

Tratamiento Avanzado

Estadio I: Tasa de curación **> 80%**

Estadio IV: Supervivencia **< 10%**

- Manejo quirúrgico prioritario.
- Inmunoterapia y Terapias Dirigidas basadas en diagnóstico genético (Ej. inhibidores de BRAF, Interferón alfa) para estadios III y IV.

Prevención y Educación del Paciente



Fotoprotección

Uso de pantallas físicas (< 2 años) y filtros químicos (> 2 años). Reaplicación obligatoria cada 2 horas (o 3-4 horas en interiores).



Evitación

Evitar exposición directa a radiación UV entre las 10:00 y las 16:00 horas.



Autoexamen

Educar al paciente sobre la vigilancia de sus propios nevos e inmediata consulta dermatológica ante el 'Signo del Patito Feo'.

BADBEAR.MED

PROYECTO BADBEAR.MED

Síguenos para más contenido médico de alto rendimiento:

Facebook | Instagram | YouTube | Rutube | Only Fans | Telegram | TikTok
@BADBEAR.MED | @BADBEARMED | @BADBEAR